

CETODOSES ET NÉMATODOSES INTESTINALES DIAGNOSTIQUÉES AU CHU DE CONSTANTINE

BELATTAR Nedjda, Laimeche S, Bendjedda F, MERRADJI A.
Laboratoire de parasitologie et de mycologie CHU de Constantine



Introduction

Les helminthiases intestinales constituent un problème de santé publique persistant et occupent une place importante dans la pathologie digestive, en raison de leurs répercussions cliniques et de leur transmission favorisée par de mauvaises conditions d'hygiène.

Notre travail est une étude rétrospective ayant pour objectif de déterminer le profil épidémioclinique et diagnostique des helminthiases intestinales chez les patients adressés au CHU de Constantine, ainsi que de répertorier les espèces helminthiques identifiées.

Matériel et méthodes

Il s'agit d'une étude rétrospective à visée descriptive qui s'est étalée du mois de janvier **2016** au mois de décembre **2025**. Elle a porté sur **10 081** prélèvements, réalisés chez des patients de différents âges des deux sexes, présentant une suspicion d'helminthiases intestinales et adressés au laboratoire de Parasitologie Mycologie du CHU de Constantine par des médecins généralistes ou spécialistes.

Les données ont été recueillies des fiches de renseignements et des registres disponibles au niveau du laboratoire.

Les cas confirmés par examen parasitologique des selles et/ou scotch-test anal ont été inclus. Les prélèvements ont fait l'objet d'un examen macroscopique et microscopique direct, complété, selon les indications par des techniques de concentration, de coloration ou d'autres techniques spécifiques.

L'identification parasitologique des espèces isolées reposait sur la mise en évidence d'un ou plusieurs éléments parasitaires: Adultes, fragments d'anneaux et/ou œufs....

Résultats

Fig1: Prévalence globale des helminthiases intestinales diagnostiquées

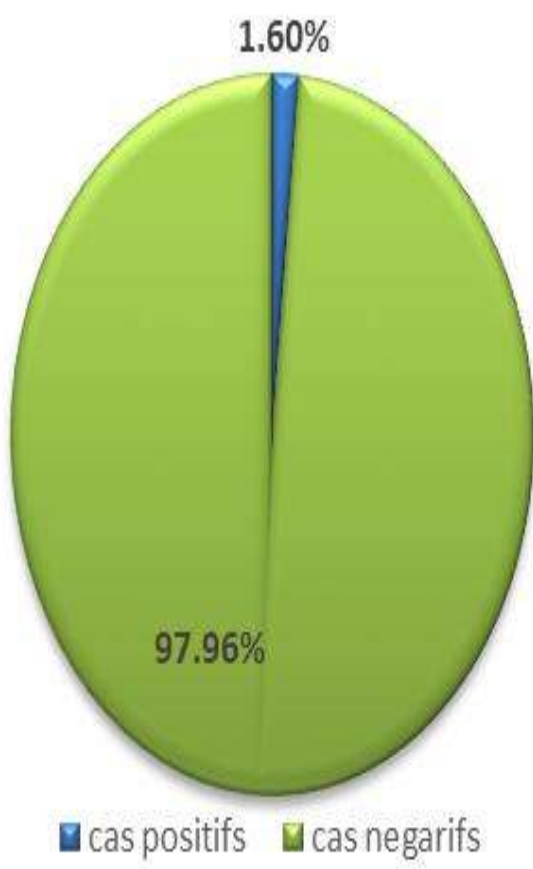


Fig5: Répartition des cas positifs de parasitisme intestinal selon l'âge

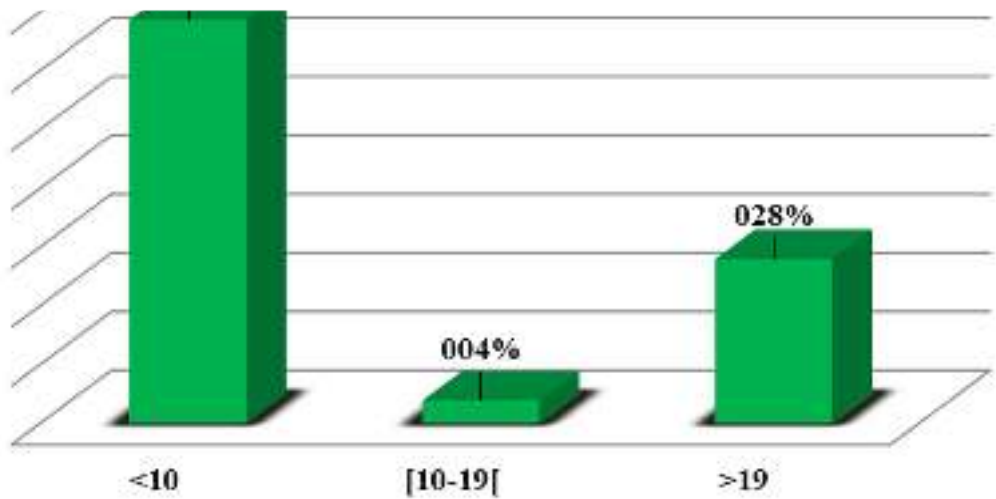


Fig5: Répartition des cas étudiés selon le type de prélèvement

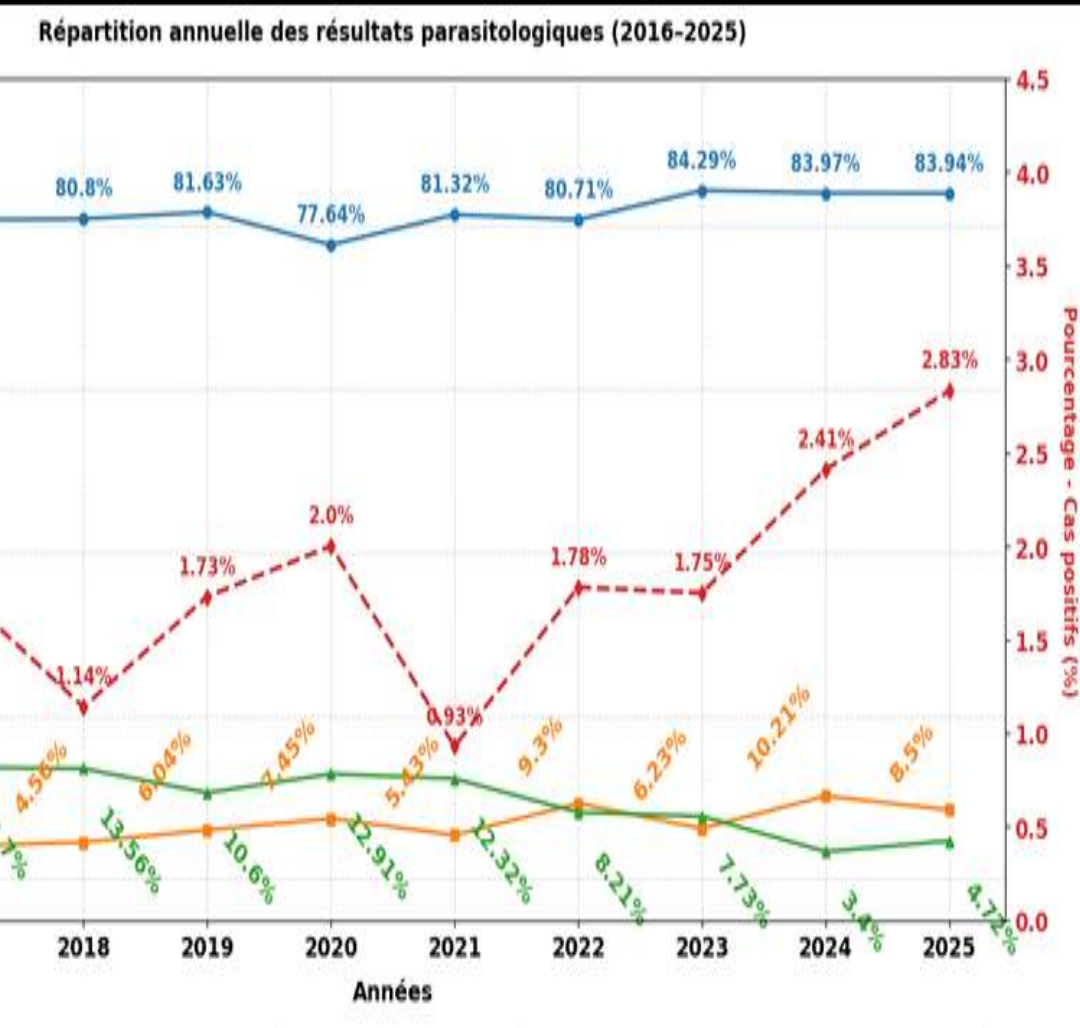


Fig4: Répartition des cas positifs des helminthes intestinaux selon le sexe

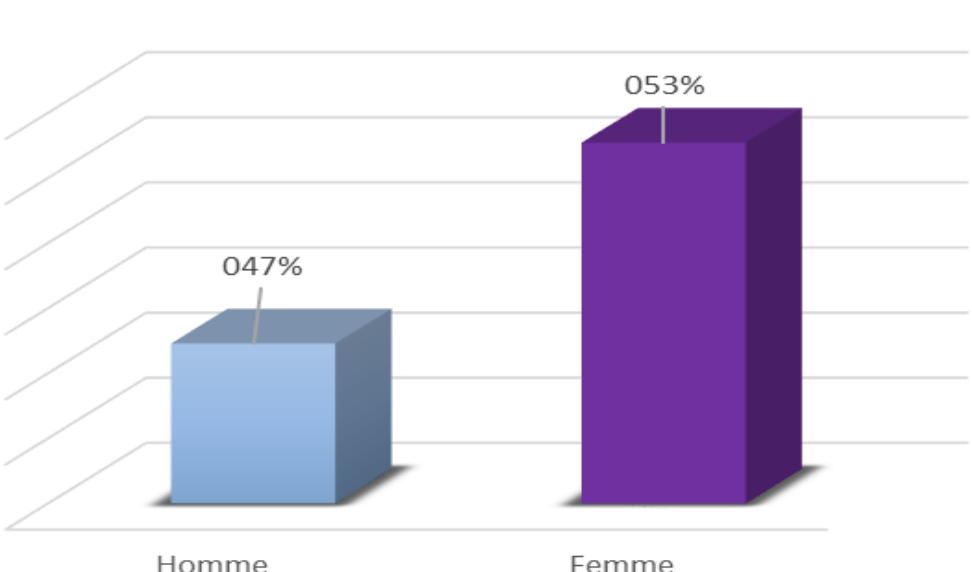


Figure 6: Répartition des cas positifs de parasitisme intestinal selon les signes cliniques

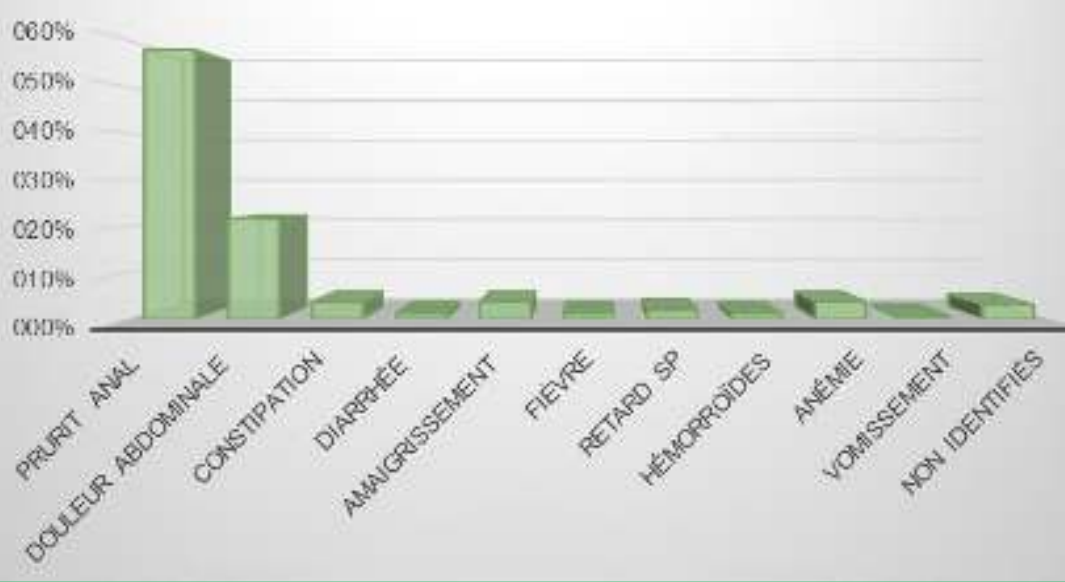


Tableau 1: Répartition des cas d'*Enterobius vermicularis* selon les caractéristiques sociodémographiques, cliniques, familiales et parasitologiques

Caractéristiques	Catégories	Fréquence	Pourcentage
Sexe	Homme	66	45.83
	Femme	78	54.17
Tranche d'âge	0-15	115	79.86%
	15-30	12	8.33%
	30-45	14	9.72%
	45-70	3	2.09%
	Prurit Anal	91	63.64%
Signes cliniques	Douleur Abdominale	20	13.99%
	Constipation	5	3.50%
	Diarrhée	5	3.50%
	Signes non spécifique	33	23.08%
	Présence	13	9.03%
Transmission Familiale	Absence	131	90.97%
	Adulte	3	2.08%
Forme parasitaire	Œuf	133	85.42%
	Ver adulte +Œuf	9	6.25%

Tableau 2 : Répartition des cas de *Taenia saginata* selon les caractéristiques sociodémographiques, cliniques, familiales et parasitologiques

Caractéristiques	Catégories	Fréquence	Pourcentage
Sexe	Homme	11	64.71%
	Femme	6	35.29%
Tranche d'âge	0-15	2	11.76%
	15-30	5	29.41%
	30-45	6	35.29%
	45-70	4	23.52%
	Prurit Anal	6	35.29%
Signes cliniques	Douleur Abdominale	4	23.53%
	Amaigrissement	2	11.76%
	Constipation	1	5.88%
	Diarrhée	1	5.88%
	Asymptomatique	3	17.65%
	Anneaux	10	58.82%
	Œufs	3	17.65%
Forme parasitaire	Anneaux+Œufs	4	23.53%

Tableau 3 : Associations parasitaires identifiées

Association parasitaire	Pourcentage
<i>E. vermicularis</i> / <i>B. hominis</i>	7.69%
<i>E. vermicularis</i> / <i>E.coli</i>	5.55%
<i>E. vermicularis</i> / <i>B. hominis</i> / <i>Taenia</i> sp	18.18%
<i>E. vermicularis</i> / <i>B. hominis</i> / <i>E. histolytica</i>	9.09%
<i>B. hominis</i> / <i>Taenia saginata</i>	7.14%
<i>Taenia saginata</i> / <i>E.coli</i>	5%

Discussion

* La prévalence globale des helminthiases intestinales déterminée (**1.60%**) est qualifiée d'intermédiaire lorsqu'elle est comparée aux données nationales et internationales disponibles. Ce qui traduit la forte hétérogénéité épidémiologique des parasitoses intestinales selon les régions, les conditions socio-économiques et les stratégies de dépistage.

Etude	Pakistan (Lubumbashi) 2025 Subhan et al.	Algérie (Sétif) 2021 Benotmane Larbi	Marroc (Marrakech) 2020 Eddehbi et al	Algérie (Blida) 2022 Hammi et al
Prévalence	66.65%	4.38%	1.61%	0.4%

* L'analyse du taux de positivité par année met en évidence des fluctuations modérées, avec des augmentations discrètes en 2017, 2019 et 2020, suivies d'une baisse en 2021. Cette régression pourrait avoir été accentuée par les perturbations des activités de dépistage et de surveillance liées à la pandémie de COVID-19. L'augmentation observée à partir de 2022 jusqu'à 2025 pourrait être expliquée par le retour à une vie sociale normale.

* La prédominance des prélèvements réalisés par scotch-test confirme son importance dans le diagnostic notamment de l'oxyurose grâce à sa facilité de réalisation, de son caractère non invasif et la fréquence élevée de cette parasitose. La faible fréquence des échantillons de selles pourrait s'expliquer par la prévalence basse des helminthiases détectables dans les selles dans la population étudiée ou une orientation diagnostique plus fréquente vers d'autres types de prélèvements selon le contexte clinique, tandis que la rareté des prélèvements de vomissements serait liée à leur caractère occasionnel et à leur moindre indication dans le diagnostic parasitologique de routine.

* Notre étude révèle une concentration quasi exclusive de l'infection à Constantine (98,76%) traduisant un biais de recrutement hospitalier ou la présence de plusieurs laboratoires d'analyses médicales dans chaque région suggère que les cas recensés concernent essentiellement la population de la région étudiée. Ce profil homogène concorde avec les travaux ciblés de Subhan et al. au Pakistan ET Jean Claudeau Gabon (2025) et Zamiche en Algérie (2024).

* Une légère prédominance féminine avec un sex-ratio (H/F) de 0,88. Ce résultat est globalement concordant avec plusieurs travaux récents, notamment ceux de Lashaki (2023), de Firdi et al. (2025), ainsi que de Jean Claude (2025), qui rapportent également une tendance à une légère prédominance féminine ou une répartition relativement équilibrée entre les deux sexes. Ces observations renforcent l'idée que la distribution selon le sexe reste globalement peu discriminante.

* L'analyse selon l'âge montre une nette prédominance des enfants de moins de 15 ans. Cette tendance rejoint les observations de Firdi et Jean Claude (2025), confirmant la vulnérabilité particulière de la population pédiatrique. Ceci peut s'expliquer par plusieurs facteurs, les enfants ne maîtrisent pas encore correctement les règles d'hygiène individuelle ainsi que la forte exposition aux environnements contaminés en milieu scolaire et familial.

* Les manifestations cliniques observées sont dominées par le prurit anal et les douleurs abdominales. Ces résultats contrastent avec les données rapportées par Waneasa, Dejon-Agobé et al. et Richert et al. (2024), qui décrivent des helminthiases intestinales souvent asymptomatiques ou peu spécifiques. Ce qui affirme la diversité des effets cliniques possibles des helminthiases qui peuvent provoquer une gêne digestive modérée à intense jusqu'à des complications.

* Enfin, on note une nette prédominance d'*Enterobius vermicularis*, constituant une particularité importante de notre série. Cette distribution contraste avec plusieurs études internationales où *Ascaris lumbricoides* est souvent l'espèce dominante, notamment celles de Badri et al.(2025) et Wondimagegn et al. (2024). Cette différence peut être liée à la prédominance d'une transmission interhumaine dans notre contexte, favorisée par la promiscuité familiale et scolaire, contrairement aux régions où la transmission géo-helminthique liée au sol est plus importante.

* Par ailleurs, le taux relativement élevé d'association protozoaires-helminthes observé dans notre étude est en accord avec les résultats de Jean Claude (2025). Ce phénomène traduit généralement une exposition répétée aux sources de contamination et une co-circulation active de plusieurs espèces parasitaires, suggérant des conditions d'hygiène insuffisantes et un environnement favorable à la transmission simultanée de plusieurs agents parasitaires.

* À noter qu'un seul cas d'ascaridiose a été identifié en 2024 suite à un vomissement chez d'un enfant de 8 ans, ce qui ne permet pas d'analyse comparative ou statistique, ce résultat reste donc descriptif et informatif.

Conclusion

L'ensemble des résultats souligne la nécessité de renforcer la prévention des helminthiases intestinales, notamment par l'amélioration des conditions d'hygiène individuelle et collective et par l'éducation sanitaire, particulièrement auprès des enfants.

Références bibliographiques

- [1] Badri, M., et al. (2025). A systematic review and meta analysis on the global prevalence of helminthic parasites among schoolchildren: a public health concern. BMC Public Health, 25(1), 2852. <https://doi.org/10.1186/s12889-025-23958-9>
- [2] Belkacem, H. (2023). Le portage parasitaire intestinal asymptomatique (Thèse de doctorat en pharmacie n° P005/2023). Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohammed V de Rabat.
- [3] Benothmane, L. (2022). La prévalence des parasites intestinaux humains dans les Wilaya de Sétif et Msila (2015-2020). Mémoire de fin d'études en vue de l'obtention du diplôme de master dans le domaine SNV.
- [4] Centers for Disease Control and Prevention(1). Clinical Overview of Pinworm infection. Disponible sur le site du CDC Pinworm Guidelines. Mis à jour en février 2024. [5].